

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Псориаз

Формы, феномены и дифференциальный диагноз

Патогенез — ось IL-23 / Th17 / IL-17; клинические формы и диагностические феномены.

Неотложные формы (пустулёзный псориаз, эритродермия) и дифференциальный ряд.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Вызов в 21:15, повод — «гнойная сыпь по всему телу, температура». Мужчина 46 лет. Псориаз около пятнадцати лет: обычно ограниченные бляшки на локтях, коленях и в области крестца, лечился наружными средствами, у дерматолога последние годы не наблюдался.

Три недели назад начал принимать преднизолон в таблетках — препарат приобрёл сам, по совету знакомого с тем же диагнозом; дозу назвать не может, «по две утром». Бляшки почти сошли. Пять дней назад упаковка закончилась, и приём прекратил разом. Через двое суток появились озноб и чувство жжения кожи, за следующие сутки на груди, животе и бёдрах возникли ярко-красные поля с мелкими гнойничками, местами сливающимися. Температура растёт третьи сутки.

Объективно: сознание ясное, вялый, отвечает односложно. Кожа: сливная яркая эритема, охватывающая грудь, живот, бёдра и сгибательные поверхности — порядка половины поверхности тела; на её фоне множественные мелкие пустулы, местами объединяющиеся в поля с гнойным содержимым. Прикосновение болезненно. Слизистые рта чистые, глаза не поражены, отслойки эпидермиса при потягивании нет. Язык сухой. Температура 39,1 °C, при этом больной дрожит и просит одеяло. АД 95/60 мм рт. ст., ЧСС 118 в минуту, ЧД 22, SpO₂ 97 % на воздухе. Мочился последний раз утром, «мало».

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. Чем эта картина отличается от гнойной инфекции кожи и почему различие не меняет объём помощи на месте?
2. Почему у пациента с горячей ярко-красной кожей возникает озноб и почему температуру измеряют, а не предполагают по виду кожи?
3. Какую роль в развитии состояния играет то, как именно был прекращён приём преднизолона?
4. Вводится ли глюкокортикоид на вызове «по поводу кожи» и при каких условиях этот вопрос решается иначе?
5. Как отграничить эту форму от токсического эпидермального некролиза?
6. Чем определяется объём инфузии и почему гипотензия здесь закономерна?

Определение и суть болезни

Псориаз — хроническое иммуноопосредованное воспалительное заболевание кожи, протекающее с обострениями и ремиссиями и нередко с системными проявлениями (суставы, сосудистый риск, метаболические нарушения). Распространённость — около 2–3 % населения.

Ключевая идея для клинициста: кожа — это орган площадью около двух квадратных метров и массой порядка четырёх килограммов. При ограниченных бляшках псориаз остаётся дерматологической проблемой, но при поражении всей поверхности (эритродермия) или лавинообразном пустулообразовании (генерализованный пустулёзный псориаз) отказывают функции кожи как органа, и состояние становится жизнеугрожающим.

Патогенез

В основе — активация оси врождённого и адаптивного иммунитета с гиперпролиферацией кератиноцитов. Упрощённая, но рабочая цепочка:

Триггер (инфекция, травма, лекарство, стресс)

↓

Активация дендритных клеток → IL-23

↓

Th17-лимфоциты → IL-17A, IL-22, ФНО-α

↓

Кератиноциты: гиперпролиферация + неполная дифференцировка

↓

Обновление эпидермиса за 3–5 суток вместо 28

↓

Паракератоз (чешуйки), акантоз (утолщение),
расширение и извитость сосудов сосочкового слоя

Из этой гистологии вытекают и внешний вид бляшки, и диагностические феномены осмотра, и системный характер тяжёлых форм: IL-17 и ФНО-α — не только «кожные» цитокины, с ними связывают ускоренный атеросклероз и коморбидность.

Клинические формы

Форма	Как выглядит	Течение
Вульгарный (бляшечный), до 90 %	Розово-красные бляшки с серебристыми чешуйками; разгибательные поверхности, волосистая часть головы, пупок, поясница	Хроническое
Каплевидный	Множественные мелкие папулы по туловищу, у молодых, через 1-3 недели после стрептококковой ангины	Часто самоограничивающееся
Инверсный	Гладкие красные очаги в складках, без чешуек	Хроническое
Ладонно-подошвенный пустулёзный	Стерильные пустулы на ладонях и подошвах	Упорное
Ногтевой	Симптом напёрстка, онихолизис, «масляные пятна»	Хроническое
Псориатический артрит	Артрит с дактилитом, энтезит, боль в спине воспалительного ритма	Прогрессирующее
Генерализованный пустулёзный (фон Цумбуша)	Волна стерильных пустул на ярко-красной коже, лихорадка, тяжёлое общее состояние	Неотложное
Эритродермия	Покраснение и шелушение более 90 % поверхности тела	Неотложное



Вульгарный (бляшечный) псориаз: чётко очерченные розово-красные бляшки с серебристо-белыми чешуйками на разгибательной поверхности.



Псориаз волосистой части головы: чешуйчатые бляшки, нередко выходящие за линию роста волос.



Каплевидный псориаз: множественные мелкие «каплевидные» папулы по туловищу; частый провокатор — перенесённая стрептококковая инфекция.



Инверсный псориаз: гладкие красные очаги в складках, чешуйки минимальны или отсутствуют из-за влажности.



Ладонно-подошвенный пустулёз: стерильные пустулы разного «возраста» — от жёлтых свежих до коричневых подсыхающих.



Ногтевой псориаз: онихолизис (отслойка ногтевой пластины) и подногтевой гиперкератоз; к другим признакам относятся точечные вдавления («симптом напёрстка») и «масляные пятна».

Диагностические феномены

Феномены осмотра — прямое следствие гистологии и позволяют распознать псориаз клинически.

Феномен	Что видно	Почему
Стеариновое пятно	При поскабливании усиливается шелушение, чешуйки как стёртый стеарин	Паракератоз, рыхлые несклеенные роговые чешуйки
Терминальная плёнка	Под чешуйками влажная блестящая поверхность	Обнажён истончённый ростковый слой
Точечное кровотечение (Ауспитца)	Мелкие капли крови	Сосуды сосочков подходят к самой поверхности
Феномен Кёбнера	Новые высыпания по линии царапины, шва, ожога	Травма запускает локальное воспаление

Первые три феномена образуют **псориатическую триаду**, последовательно выявляемую при поскабливании бляшки (граттаж).

Псориатический артрит и дактилит

Псориатический артрит развивается у части больных и может как следовать за кожными проявлениями, так и предшествовать им. Характерны асимметричный олигоартрит, энтезит (воспаление в местах прикрепления сухожилий), боль в спине воспалительного ритма и **дактилит** — равномерный отёк пальца целиком («палец-сосиска»).



Дактилит («палец-сосиска»): диффузный отёк всего пальца — сочетание артрита и теносиновита, типичное для псориатического артрита.

Неотложные формы

Генерализованный пустулёзный псориаз (фон Цумбуша)

Самостоятельное состояние, а не «псориаз потяжелее». Развивается за часы-дни: внезапная лихорадка 38–40 °С, жжение и болезненность кожи, затем волна мелких **стерильных** пустул на ярко-красном фоне, сливающихся в «гнойные озёра». Волны повторяются.

Тяжесть определяется системностью процесса:

- системный воспалительный ответ, по картине неотличимый от сепсиса;
- поражение внутренних органов: острое повреждение печени, почечная недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром;
- гиповолемия и гипоальбуминемия;
- вторичная бактериальная инфекция поверх стерильного воспаления.

Пустулы стерильны, но клинически это не отличимо от гнойной инфекции — стерильность подтверждается только посевом. Поэтому до исключения инфекции состояние ведётся как септическое.

Герпетиформное импетиго — генерализованный пустулёзный псориаз беременных, чаще в третьем триместре; может быть первой в жизни манифестацией (нередко на фоне гипокальциемии). Угрожает плоду плацентарной недостаточностью и мертворождением.



Генерализованный пустулёзный псориаз (фон Цумбуша): волна стерильных пустул на ярко-эритематозном фоне, местами сливающихся в «гнойные озёра».



Герпетиформное импетиго: пустулы по периферии эритематозных очагов у беременной — вариант генерализованного пустулёзного псориаза.

Псориазическая эритродермия

Поражение и шелушение более 90 % поверхности тела. Когда воспалена вся кожа, одновременно отказывают все её функции.

Утраченная функция	Следствие	Клинические проявления
Барьер для воды	Потеря жидкости через кожу до 3–4 л/сут	Жажда, сухость языка, олигурия, тахикардия, гипотензия
Терморегуляция	Расширение сосудов, усиленное испарение	Гипотермия , озноб; при инфекции — лихорадка
Барьер для микробов	Входные ворота площадью в кв. метры	Сепсис — главная причина смерти
Удержание белка	Потеря 20–30 г белка в сутки с чешуйками	Отёки, гипоальбуминемия
Регуляция кровотока	Массивная вазодилатация, шунтирование	Сердечная недостаточность с высоким выбросом
Электролитный гомеостаз	Потери натрия, калия, кальция	Аритмии, судороги

Контринтуитивная деталь: несмотря на ярко-красную, горячую на вид кожу, пациент **мёрзнет** — теплоотдача превышает теплопродукцию. Гипотермия при эритродермии типична. Образно эритродермию называют «ожогом без огня».



Псориазическая эритродермия: сливная эритема, охватывающая практически весь кожный покров (>90 %).



Та же форма, крупный план: диффузная эритема с крупнопластинчатым шелушением — «ожог без огня».

Триггеры обострения

Значимая часть провокаторов — лекарственные, и это определяет их клиническую важность.

Провокатор	Механизм и оговорка
Системные глюкокортикоиды — назначение и особенно резкая отмена	Классический пусковой механизм пустулёзного криза и эритродермии (синдром рикошета)
Бета-адреноблокаторы	Обострение через недели-месяцы; чаще неселективные
Препараты лития	Устойчивое обострение
Антималярийные (гидроксихлорохин)	Обострение, иногда тяжёлое
НПВС	Могут ухудшать течение
Интерфероны, ингибиторы АПФ, тетрациклины, тербинафин	Описаны как провокаторы
Отмена метотрексата или биологической терапии	Синдром рикошета вплоть до пустулёзной формы

Нелекарственные: стрептококковая инфекция (особенно каплевидная форма), ВИЧ, гипокальциемия, беременность и роды, тяжёлый стресс, солнечный ожог, травма кожи, переохлаждение.

Клинически важно: системный глюкокортикоид, назначенный или отменённый у больного псориазом «по поводу кожи», способен спровоцировать пустулёзный криз. При этом при витальных показаниях (анафилаксия, тяжёлая бронхообструкция, отёк гортани, надпочечниковая недостаточность) глюкокортикоид применяется по своим протоколам независимо от псориаза.

Дифференциальный диагноз эритродермии

Эритродермия — синдром, а не диагноз. Наибольшее значение имеет отграничение псориатической эритродермии от токсического эпидермального некролиза, требующего иного маршрута и иной скорости.

Причина	Отличительные признаки
Псориатическая	Известный псориаз в анамнезе, остаточные бляшки, ногтевые изменения, крупнопластинчатое шелушение
Экзематозная	Анамнез атопии, мокнутие, интенсивный зуд
Лекарственная / DRESS	Начало через 2–8 недель после нового препарата, отёк лица, лимфаденопатия, поражение печени
AGEP (ОГЭП)	Пустулы, остро в течение 1–2 суток после препарата, быстро разрешается после отмены
ССД / ТЭН	Поражение слизистых, болезненность кожи, отслойка эпидермиса пластами, положительный симптом Никольского
Т-клеточная лимфома кожи	Пожилые, длительный анамнез резистентной «экземы», лимфаденопатия
Норвежская (корковая) чесотка	Иммунодефицит, массивные корки, крайняя контагиозность

Симптом Никольского: при боковом надавливании на видимо здоровую кожу рядом с очагом эпидермис сдвигается и отслаивается. При псориазе отрицательный; положительный уводит к токсическому эпидермальному некролизу и пузырьным дерматозам.



Атопическая экзема: эритема, мокнутие и следы расчёсов; при генерализации даёт экзематозную эритродермию.



Атопическая экзема: лихенификация и эксориации в типичной локализации.



Атопическая экзема: воспалённые шелушащиеся очаги; ключ к диагнозу — анамнез атопии и интенсивный зуд.



DRESS-синдром: распространённая лекарственная сыпь с отёком лица; часты лимфаденопатия и поражение печени.



Острый генерализованный экзантематозный пустулёз (AGEP): множество мелких стерильных пустул на отёчной эритеме, остро после приёма препарата.



Токсический эпидермальный некролиз / синдром Стивенса-Джонсона: отслойка эпидермиса пластами и поражение слизистых — маршрут как при ожоге, максимальная срочность.



Эритродермическая Т-клеточная лимфома кожи (синдром Сезари): диффузная эритема у пожилого пациента с длительным резистентным анамнезом.



Ранняя корковая (норвежская) чесотка: начинающиеся гиперкератотические наслоения.



Норвежская (корковая) чесотка: массивные гиперкератотические корки; развивается при иммунодефиците, крайне контагиозна.

Один горячий сустав: псориатический артрит или септический

У больного псориазом остро воспалённый сустав нельзя автоматически относить к обострению псориатического артрита: под этой маской скрывается септический артрит, разрушающий сустав за сутки.

	Псориатический артрит	Септический артрит	Подагра
Начало	Дни-недели	Часы-сутки	Часы, ночью
Лихорадка	Редко	Часто	Возможна субфебрильная
Число суставов	Несколько, асимметрично; дактилит	Один , чаще колено	Один, чаще первый плюснефаланговый
Движение	Скованность, боль при нагрузке	Полная невозможность движения	Резкая боль от прикосновения
Риск	Функциональный	Разрушение сустава, сепсис	Функциональный

На фоне биологической терапии (ингибиторы ФНО-α, IL-17, IL-23) септический артрит и другие инфекции протекают **без выраженной лихорадки** и без ярких лабораторных сдвигов — субфебрилитет у такого пациента эквивалентен высокой температуре у иммунокомпетентного.

Возвращение к клиническому случаю

Диагноз бригады. Генерализованный пустулёзный псориаз, форма фон Цумбуша, с системным воспалительным ответом и гиповолемией. Опорные признаки: известный псориаз в анамнезе, развитие за сутки-двое, лихорадка, болезненность кожи, волна мелких пустул на сливной эритеме, отсутствие поражения слизистых и отрицательный симптом отслойки эпидермиса.

Пустулы стерильны, но лечится это как инфекция. Отличить стерильное пустулообразование от гнойной инфекции у постели невозможно — стерильность подтверждается только посевом. Для бригады это означает простое правило: разграничение не влияет на объём помощи, поскольку и то и другое требует госпитализации и ведения как септического состояния. Более того, вторичная бактериальная инфекция поверх стерильных пустул — типичное осложнение, а не альтернативная версия.

Гипотензия здесь закономерна. Воспалённая кожа перестаёт удерживать воду: потери через покров при распространённом процессе достигают нескольких литров в сутки, к ним добавляется потеря белка с чешуйками и массивная вазодилатация. Тахикардия 118, давление 95/60, сухой язык и олигурия с утра — это дефицит объёма на фоне системного воспаления, а не «слабость от температуры». Инфузия натрия хлорида 0,9 % начинается на месте, под контролем гемодинамики; при сохраняющейся гипотензии объём и темп определяются по реакции, а не по формальной цифре.

Озноб при температуре 39. Кожа с расширенными сосудами теряет тепло быстрее, чем организм его производит, поэтому больной с ярко-красным горячим на вид покровом субъективно мёрзнет. При эритродермии типична именно гипотермия — и это ловушка: температуру измеряют, а не выводят из внешнего вида кожи. У этого пациента лихорадка есть, и она указывает на системный воспалительный ответ либо на присоединившуюся инфекцию; отсутствие лихорадки не сделало бы состояние легче.

Роль преднизолона. Резкая отмена системного глюкокортикоида у больного псориазом — классический пусковой механизм пустулёзного криза, синдром рикошета. Здесь сработала полная последовательность: бесконтрольный приём препарата «по поводу кожи», заметное улучшение, обрыв приёма разом. Практический вывод для линии — вопрос, который стоит задавать любому больному псориазом с внезапным ухудшением: что принимал внутрь и что перестал принимать в последние недели. Отмена метотрексата или биологической терапии даёт тот же эффект.

Глюкокортикоид на вызове не вводится «по поводу кожи». Возобновление системной терапии — решение стационара, и оно неоднозначно именно потому, что глюкокортикоид способен и провоцировать, и утяжелять пустулёзные формы. Оговорка остаётся прежней: при витальных показаниях — анафилаксия, тяжёлая бронхообструкция, отёк гортани, надпочечниковая недостаточность — глюкокортикоид применяется по своим протоколам независимо от псориаза.

Отграничение от токсического эпидермального некролиза. Здесь оно выполнено объективно: слизистые чистые, глаза не поражены, эпидермис при потягивании не отслаивается, ведущий элемент — пустула на эритеме, а не сливная болезненная эритема с отслойкой. При некролизе картина обратная: обязательное поражение слизистых, положительный симптом Никольского, связь с приёмом нового препарата за

одну–три недели, — и это другой маршрут, в ожоговый центр или реанимацию, с другой скоростью.

Что не делать. Не вскрывать и не обрабатывать пустулы, не наносить на месте наружные средства, не фиксировать пациента жёсткими лямками по поражённой коже и вообще минимизировать травматизацию покрова: механическое повреждение кожи у больного псориазом само является провокатором новых элементов. Пациента укрыть — потеря тепла реальна, несмотря на лихорадку.

Маршрут. Многопрофильный стационар, а не участковый дерматолог и не «направление в поликлинику»: сочетание распространённого пустулёзного процесса с гипотензией и олигурией означает риск сепсиса, острого повреждения печени и почек, респираторного дистресс-синдрома. В передаче звучат площадь поражения, давность волны пустул, лихорадка, показатели гемодинамики, объём введённой жидкости и — обязательно — факт трёхнедельного приёма преднизолона с резкой отменой.

Ответы на вопросы для размышления

1. Отличить стерильные пустулы от гнойной инфекции у постели невозможно — стерильность подтверждается только посевом. Различие не меняет объём помощи: и то и другое требует госпитализации и ведения как септического состояния. Вторичная бактериальная инфекция поверх стерильных пустул — типичное осложнение.
2. Кожа с расширенными сосудами теряет тепло быстрее, чем организм его производит, поэтому больной с ярко-красным горячим на вид покровом субъективно мёрзнет. При эритродермии типична гипотермия. Температуру измеряют, а не выводят из внешнего вида кожи.
3. Резкая отмена системного глюкокортикоида — классический пусковой механизм пустулёзного криза (синдром рикошета). Бесконтрольный приём «по поводу кожи», улучшение, обрыв разом. Тот же эффект даёт отмена метотрексата или биологической терапии.
4. Глюкокортикоид на вызове не вводится «по поводу кожи»: возобновление системной терапии — решение стационара, препарат способен и провоцировать, и утяжелять пустулёзные формы. При витальных показаниях — анафилаксия, тяжёлая бронхообструкция, отёк гортани, надпочечниковая недостаточность — применяется по своим протоколам независимо от псориаза.
5. Здесь слизистые чистые, глаза не поражены, эпидермис при потягивании не отслаивается, ведущий элемент — пустула на эритеме. При токсическом эпидермальном некролизе — обязательное поражение слизистых, положительный симптом Никольского, связь с новым препаратом за одну–три недели; маршрут — ожоговый центр или реанимация.
6. Воспалённая кожа не удерживает воду: потери через покров достигают нескольких литров в сутки, плюс потеря белка с чешуйками и вазодилатация. Тахикардия, давление 95/60, сухой язык и олигурия — дефицит объёма. Инфузия натрия хлорида 0,9 % начинается на месте; темп определяется по реакции гемодинамики.

Источники иллюстраций

Клинические фотографии — [DermNet](#), CC BY-NC-ND 4.0. Водяной знак сохранён, кадры не кропались и не ретушировались. Атрибуция: Image sourced from DermNet.

Файл	Что изображено	Страница DermNet
vulgaris.png	Вульгарный (бляшечный) псориаз	Psoriasis
scalp.png	Псориаз волосистой части головы	Scalp psoriasis
guttate.png	Каплевидный псориаз	Guttate psoriasis
inverse.jpg	Инверсный псориаз	Flexural psoriasis
palmoplantar_pustulosis.png	Ладонно-подошвенный пустулёз	Palmoplantar pustulosis
nail.png	Ногтевой псориаз	Nail psoriasis
dactylitis.png	Дактилит	Psoriatic arthritis
generalized.jpg	Генерализованный пустулёзный псориаз	Generalised pustular psoriasis
impetigo_herpetiformis.png	Герпетиформное импетиго	Impetigo herpetiformis
erythroderma.png, erythroderma_2.png	Псориатическая эритродермия	Erythroderma
eczema_1.jpg, eczema_2.jpg, eczema_3.jpg	Атопическая экзема	Atopic dermatitis
dress.jpg	DRESS-синдром	DRESS syndrome
ager.jpg	AGEP	Acute generalised exanthematous pustulosis
ten_sjs.jpg	Токсический эпидермальный некролиз / ССД	Toxic epidermal necrolysis
ctcl_sezary.jpg	Эритродермическая Т-клеточная лимфома кожи	Cutaneous T-cell lymphoma
crusted_scabies_1.jpg, crusted_scabies_2.jpg	Корковая (норвежская) чесотка	Crusted scabies

Выходные данные

Материал: «Псориаз». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Клинические фотографии DermNet — CC BY-NC-ND 4.0, водяной знак сохранён. Копировать и печатать текст можно свободно; продавать нельзя; при переработке текста сохраняется CC BY-NC-SA 4.0. Кадры DermNet не модифицируются.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты и названия стационара. Совпадения с чужой практикой возможны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.